OMALGIA

La omalgia se define como el dolor localizado en la articulación del hombro. Desde el punto de vista clínico, no se considera un diagnóstico definitivo en sí mismo, sino un síndrome doloroso que requiere una búsqueda etiológica específica para determinar su origen exacto.

¿A qué se debe?

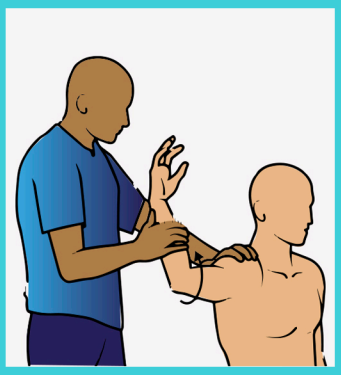


El principal mecanismo fisiopat_ológico en la omalgia de origen musculoesquelético.

Es la inflamación y degeneración tisular. El espacio subacromial es estrecho cuando hay sobrecarga o debilidad muscular, se produce una fricción que inflama los tendones, generando dolor y limitación funcional.

Causas

La omalgia es de etiología multifactorial, el origen más frecuente (aproximadamente el 70% de los casos) se debe a patologías del manguito rotador, especialmente por el pinzamiento subacromial y del tendón del supraespinoso.



Consecuencias

Dificultad para realizar actividades de la vida diaria como vestirse, peinarse o levantar objetos asi mismo la disminución de la movilidad (capsulitis secundaria) y atrofia muscular por desuso. ademas del dolor nocturno.

Objetivos de la rehabilitacion

Nos centramos en que la recuperacion sea coservadora y funcional.

* Eliminar y reducir el dolor
* Recuperar movilidad
* Fortalecer y tonificar la musculatura
* Educación y autogestión



OMALGIA

La omalgia se define como el dolor localizado en la articulación del hombro. Desde el punto de vista clínico, no se considera un diagnóstico definitivo en sí mismo, sino un síndrome doloroso que requiere una búsqueda etiológica específica para determinar su origen exacto.

¿A qué se debe?

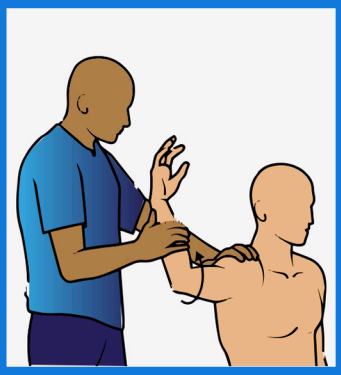


El principal mecanismo fisiopat_ológico en la omalgia de origen musculoesquelético.

Es la inflamación y degeneración tisular. El espacio subacromial es estrecho cuando hay sobrecarga o debilidad muscular, se produce una fricción que inflama los tendones, generando dolor y limitación funcional.

Causas

La omalgia es de etiología multifactorial, el origen más frecuente (aproximadamente el 70% de los casos) se debe a patologías del manguito rotador, especialmente por el pinzamiento subacromial y del tendón del supraespinoso.



Consecuencias

Dificultad para realizar actividades de la vida diaria como vestirse, peinarse o levantar objetos asi mismo la disminución de la movilidad (capsulitis secundaria) y atrofia muscular por desuso. ademas del dolor nocturno.

Objetivos de la rehabilitacion

Nos centramos en que la recuperacion sea coservadora y funcional.

* Eliminar y reducir el dolor
* Recuperar movilidad
* Fortalecer y tonificar la musculatura
* Educación y autogestión

